

Botulinumtoxin bei muskulärer CMD

Bei ausgeprägten Beschwerden der Kaumuskulatur kann eine vorübergehende Muskelentspannung durch Botulinumtoxin erwogen werden. Entscheidend sind eine gesicherte Einordnung Ihrer Beschwerden, realistische Ziele und die Abwägung gegenüber konservativen Möglichkeiten.

CMD und Bruxismus unterscheiden

Eine craniomandibuläre Dysfunktion, kurz CMD, betrifft die Kaumuskeln, Kiefergelenke oder deren Zusammenspiel. Bruxismus bedeutet wiederholtes Pressen, Knirschen oder Anspannen des Kiefers im Wachzustand oder im Schlaf. Beides kann zusammen auftreten, ist aber nicht gleichbedeutend.

Muskelbedingte Schmerzen, Verspannungen und Beschwerden beim Kauen können eine Rolle spielen. Zahnprobleme, entzündliche oder strukturelle Gelenkveränderungen und andere Schmerzursachen müssen davon unterschieden werden. Ein Knacken allein begründet keine Injektion.

Was die Behandlung bewirken kann

Botulinumtoxin Typ A dämpft vorübergehend die Signalübertragung vom Nerv auf den behandelten Muskel. Die Muskelkraft kann abnehmen; damit können bestimmte Überlastungsbeschwerden gelindert werden. Meist werden ausgewählte Kaumuskeln, beispielsweise der Masseter und je nach Befund der Schläfenmuskel, berücksichtigt.

Ein mögliches Ziel

Weniger muskulärer Schmerz oder Überlastung und eine bessere Alltagsfunktion. Vorher halten wir fest, woran eine Besserung bei Ihnen erkennbar wäre.

Eine wichtige Grenze

Die Häufigkeit des Pressens oder Knirschens muss nicht abnehmen. Gelenkschäden und andere Ursachen werden nicht behoben. Die Wirkung ist zeitlich begrenzt.

Wann wir diese Möglichkeit abwägen

Insbesondere bei hohem Leidensdruck, passendem muskulärem Befund und unzureichender Besserung durch geeignete konservative Maßnahmen. Die deutsche Bruxismus-Leitlinie 2026 lässt Botulinumtoxin bei Erwachsenen als erwägbare Maßnahme zu, bei niedriger Evidenzsicherheit. Für chronischen CMD-Schmerz insgesamt bewerten andere Leitlinien den Einsatz zurückhaltender.

Off-Label-Use: Die Behandlung von CMD beziehungsweise Bruxismus gehört nicht zu den dafür zugelassenen Anwendungsgebieten. Erwarteter Nutzen, Unsicherheiten, Risiken und Alternativen werden deshalb ausdrücklich besprochen. Eine Besserung ist nicht garantiert.

Welche Alternativen und Begleitmaßnahmen gibt es?

Zur Basis gehören Information über die Beschwerden, Selbstbeobachtung und angemessene Belastung. Je nach Befund kommen physiotherapeutische Übungen, manuelle Behandlung sowie Entspannungs- oder verhaltensbezogene Ansätze infrage. Eine passende Schiene kann die Zähne schützen; sie ist nicht für jede Schmerzursache eine Lösung.

Schlaf, Stress, Medikamente und begleitende Erkrankungen werden berücksichtigt. Bei anhaltenden oder vielschichtigen Schmerzen kann eine interdisziplinäre Behandlung sinnvoll sein. Auch ohne Injektion können konservative Maßnahmen weitergeführt oder angepasst werden.

Vorbereitung und Untersuchung

- Beschwerden, Verlauf und bisherige Therapien besprechen; gegebenenfalls Schiene und vorhandene Befunde mitbringen.
- Alle Medikamente und frühere Botulinumtoxin-Behandlungen mit Datum und Präparat angeben. Bestimmte Antibiotika und muskelwirksame Medikamente können die Wirkung verändern.
- Allergien, Muskel- oder Nervenerkrankungen, Schluck- oder Atemprobleme sowie Schwangerschaft oder Stillzeit mitteilen. Gerinnungshemmer nicht eigenständig absetzen.
- Bei Infektion im Behandlungsgebiet oder fehlender Eignung wird nicht injiziert. In Schwangerschaft und Stillzeit wird eine elektive Behandlung verschoben.

So läuft die Behandlung ab

Nach Untersuchung der Kaumuskulatur und Kieferfunktion legen wir Muskeln, Seiten und Umfang fest. Die Haut wird desinfiziert; anschließend erfolgen kleine Injektionen mit feinen Nadeln. Dosierung und Verteilung sind individuell und präparatspezifisch. Sie bleiben wach.

Betäubung: Die Einstiche können kurz schmerzen. Eine Sedierung oder Vollnarkose ist normalerweise nicht erforderlich. Bei Bedarf besprechen wir Kühlung oder geeignete lokale Maßnahmen. Eine pauschale Schmerzfreiheit wird nicht versprochen.

Mögliche Risiken

- Schmerz, Rötung, Schwellung, Bluterguss, Infektion, Kopfschmerz oder allergische Reaktion.
- Vorübergehend schwächeres Kauen, verändertes Lächeln, Asymmetrie oder Mundtrockenheit durch Mitwirkung benachbarter Strukturen.
- Abnahme des Muskelumfangs und Veränderung der Gesichtskontur. Langfristige Muskel- und Knochenveränderungen bei wiederholter Behandlung sind nicht abschließend geklärt.
- Selten über die Zielregion hinausgehende Muskelschwäche und Sprech-, Schluck- oder Atemstörungen. Schwere allergische Reaktionen sind selten, aber möglich.

Wirkverlauf und Kontrolle

Die Wirkung beginnt verzögert, meist innerhalb der ersten Tage bis Wochen. Bei einem Kontrolltermin, häufig nach 2–4 Wochen, beurteilen wir Schmerzen, Kaukraft, Funktion und Nebenwirkungen. Die Wirkung klingt nach einigen Monaten wieder ab; Dauer und Nutzen unterscheiden sich individuell.

Eine erneute Behandlung wird anhand des Verlaufs neu entschieden. Dabei gelten präparatspezifische Mindestabstände. Häufiges Nachspritzen ist kein Ersatz für eine erneute Diagnostik. Bei unzureichender Wirkung wird der Plan überprüft.

Was Sie nach der Behandlung beachten

Die Einstichstellen nicht kräftig reiben oder massieren. Am Behandlungstag intensive körperliche Belastung, starke Wärme und Alkohol vermeiden. Diese Hinweise dienen auch dazu, lokale Reaktionen gering zu halten. Vereinbarte Übungen oder eine geeignete Schiene bleiben Teil Ihres Behandlungsplans.

Bei ausgeprägter Kauschwäche, zunehmender Schwellung, Schmerzen oder auffälliger Asymmetrie bitte Kontakt aufnehmen. Bei Seh- oder anderen relevanten Funktionsstörungen nicht selbst fahren. Schmerzmittel nur bei Bedarf nach persönlicher Empfehlung; Medikamente nicht eigenmächtig ändern.

Neue Sprech-, Schluck- oder Atemstörungen sowie ausgeprägte allgemeine Muskelschwäche müssen sofort ärztlich abgeklärt werden.

Praxis **06151 786540**. Nach der Behandlung außerhalb der Praxissprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: **112**.

Kosten und Eigenleistung

Die Behandlung wird in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Die Kosten werden vorab **individuell als Eigenleistung** vereinbart. Umfang, Nachkontrolle und mögliche Wiederholungen werden transparent besprochen; eine Erstattung wird nicht zugesagt.

Häufige Fragen

Verswindet das Knirschen vollständig?

Das ist nicht zu erwarten. Die Behandlung kann die Muskelkraft vermindern, ohne das zugrunde liegende Verhalten zu beseitigen. Zahnschutz und weitere Maßnahmen bleiben wichtig.

Lässt sich die Wirkung sofort rückgängig machen?

Nein. Es gibt keine einfache sofortige Auflösung. Unerwünschte Wirkungen werden ärztlich beurteilt und bei Bedarf behandelt; die Muskelwirkung muss meist abklingen.

Checkliste für das Gespräch

Diagnose und Behandlungsziel verstanden? Konservative Möglichkeiten geprüft? Off-Label-Use und Risiken besprochen? Kosten, Kontrolltermin und Kontaktweg bekannt?

Fachliche Grundlagen

DGFD/DGZMK: S3 Bruxismus, 2026, Empfehlung 24; BMJ: Chronic TMD pain guideline, 2023; Fachinformation Botulinumtoxin Typ A. Abruf 13.09.2026. Die konkrete Anwendung richtet sich nach Ihrem Befund und den Angaben zum ausgewählten Präparat.